

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUIZ RIBEIRO PINTO

IDADE: 69 PESO: 90 ALTURA: 1,70 PROFISSÃO: gerente de montanhismo.

SINTOMAS: Sonolência

QUEIXAS: Boca seca / Trepagava do nada / pernas inchadas.

MEDICAMENTOS: Anconon / Sildenafil / Triptans / Truxal / Sertualina

HAS / DM / Colesterol

MÉDICO: Dr. Mário Jorge

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 5h / 5:30

COCHILHO (X) S () N 15' DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE /

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (X) X NA SEMANA () N espera roncã

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 4x 5x (2ª fase da noite)

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: manual CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: da noite

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 41.1 SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hernia do esôfago / neuropatia Déficit auditivo / 6 dentes

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA frutinha

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S (X) N SPO2 CI/CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

28/10/24 Avaliação - trip tudo

04/11/24 P= 8.2 cmH₂O Bem adaptado pudera para ir
IAH= 0.4 e/h Sem queixa Suave
m. de uso: 6h55 min
fuga: 17 l/min.

11/11/24 P= 8.2 cmH₂O
IAH= 0.3 e/h Suave
m. de uso: 6h10 min.

25/11/24 P= 8.2 cmH₂O Bem adaptado relata que não
IAH= 0.3 e/h está c/ sonolência diurna. sua
m. de uso: 6h4'

08/01 P= 8.2 cmH₂O - Relata que a perna inchada
IAH= 0.5 e/h orienta proc. nefro e vas.
m. de uso: 6h47' - não está indo ao banheiro.
fuga: 0.0 lpm. foi claudica

11/02/25 $P=8,2 \text{ cmHgO}$
 $IAH=2,5 \text{ e/h}$
mde uxo: 6h6'
fuq: $\emptyset$

Bem adaptado
S/queixas

Natacha

Mário Silva Jorge

NEUROLOGIA - CRM 27.123

Membro Efetivo da Academia Brasileira de Neurologia

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica

Member's of International Headache Society

Doutor em Neurologia - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)

Médico do Grupo de Neurologia Cognitiva do HC - FMUSP

A

ANA CLAUDIA

Encarregado 11 segs avaliacor

O paciente Luiz Mend Pinto

q. pedo de SAOS

Dr. Mário Silva Jorge
Neurologista
CRM 27123

INEP - Instituto do Cérebro - Clínica da Memória

Rua Santa Clara, 450 - Vila Adyana - São José dos Campos - SP

Telefones: (12) 3921-2071 / 3202-8050 / 3921-4177

Celular: (12) 99125-7193 - WhatsApp

Clinica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Luiz Ribeiro Pinto

EXAME nº: 5595

SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge

DATA: 28/08/2024

IDADE: 69 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 21h33min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 11 minutos e a latência para o estágio REM, de 138 minutos. O tempo total de sono foi de 426 minutos (07h06min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 85,8%. A distribuição do sono mostrou 14,3% de estágio 1, 64% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 21,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 59,5 minutos em vigília, ocorreram 204 microdespertares (índice: 28,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 43,4/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 41,1/hora, sendo 14,9 apneia/hora e 26,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 42/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 93% e a mínima de 82%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono

TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (41,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (42/hora), algumas dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 48; máxima: 61 bpm.

O ronco foi contínuo e alto.

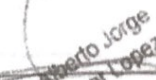
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 11 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (138 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (85,8%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 28,7/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (14,3%; normal: 8-10%), 2 (64%; normal: 45-55%) e REM (21,7%; normal: 20%). Sem estágio 3 (0%; normal: 10-12%).

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (43,4/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 9 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

CPAP

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730